

Dermatomykose:

Dermatomykose steht für eine lokale Pilzinfektionen der Haut, meist durch Dermatophyten und Hefen. Häufigste infektiös bedingte Hauterkrankungen überhaupt. In der Regel harmlos.

Candidose (Haut- und Schleimhautsoor) steht für eine Erkrankung der Haut- und Schleimhäute durch einen Hefepilz, am häufigsten *Candida albicans*.

Die Beschwerden hängen ab von der Lokalisation der Erkrankung.

Im Bereich der Zehenzwischenräume ähneln sich Dermatophyten- und Candidabefall so sehr, dass eine Differenzierung klinisch kaum möglich ist. Die Haut ist gerötet, eingerissen, schuppt und juckt stark. Da über die Rhagaden Bakterien eindringen können, ist das Bild vielfach durch Superinfektion maskiert. Die Fußsohle ist oft ebenfalls gerötet und schuppt.

Bei Nagelbefall verfärbt sich die Nagelplatte gelb-bräunlich. Später wird der Nagel dicker und höckerig. Mykosen durch Dermatophyten beginnen meist am freien Rand des Nagels, Candidamykosen eher am Nagelwall.

Am übrigen Körper können Dermatophyten- und Candidabefall oft mit dem bloßen Auge unterschieden werden. Typisch für Dermatophyten sind scheibenförmige, relativ scharf begrenzte, gerötete und schuppene Herde, die in der Mitte abblassen und sich ringförmig ausbreiten. Der „Randwall“ ist dunkler und zum Teil erhaben.

Charakteristisch für *Candida* sind eine entzündlich gerötete Haut mit Pusteln, eine nach innen gerichtete Schuppenkrause am Rand des Herds und Satelliten-Pusteln in der Umgebung. Eventuell bestehen weißliche Beläge oder blutende Läsionen. Sehr häufig vor allem bei Kindern im ersten Lebenshalbjahr ist der Windelsoor, der sich von der „einfachen“ Windeldermatitis durch die Satelliten-Pusteln unterscheidet. Juckreiz ist bei beiden möglich.

Dermatophyten können auch die Haare befallen. Leitsymptom ist das Abbrechen der Haare knapp oberhalb der Kopfhaut. Je nach Stärke der entzündlichen Reaktion sind deutliche, rötliche Hautherde, eventuell mit Pusteln und Krusten, erkennbar. Die Verdachtsdiagnose wird anhand des Untersuchungsbefunds gestellt. Eine sichere Diagnose erfordert jedoch den Erregernachweis.

Oft können die fadenförmigen oder rundlichen Pilze bereits unter dem Mikroskop gesehen werden. Besonders geeignet sind Haare, Schuppen oder Nagelspäne aus den Herdrändern. Eine genaue Identifizierung der Erreger gelingt durch Pilzkultur.

Bei Dermatophytenbefall müssen Haustiere der Betroffenen vom Tierarzt untersucht werden, da sie eine häufige Ansteckungsquelle sind. Dermatomykosen der Haut werden mit lokalem Antimykotika behandelt, z. B. Ciclopirox (z. B. Selergo®) oder Clotrimazol (z. B. Canesten®). Bei starker entzündlicher Reaktion und Jucken kann zuvor ein Antimykotikum-Glukokortikoid-Kombinationspräparat (z. B. Lotricomb®) nötig sein.

Bei Nagelbefall unter 50 % des Nagels werden antimykotische Nagellacke (z. B. Ciclopoli®, Loceryl®) über 9–12 Monate aufgetragen. Bei stark verdickter Nagelplatte kommt es zur Reduktion der Pilze ein nichtinvasives Abtragen der Nagelplatte mithilfe hochprozentiger Harnstoffsalben (z. B. Onyster® Nagelset) in Betracht. Die Harnstoffsalbe wird auf den Nagel aufgetragen und mit Plastikfolie bedeckt, die umliegende Haut durch Zinkpaste geschützt. Nach mehrtägiger Wiederholung lässt sich der Nagel nach einem warmen Fußbad abtragen.

Bei Befall der Nagelmatrix oder Erfolglosigkeit der Lokaltherapie ist die orale Gabe von Antimykotika angezeigt, etwa Terbinafin (z. B. in Terbiderm®) oder Itraconazol (z. B. in Itraderm®). Diese Behandlung muss längere Zeit, bei Nagelbefall einige Monate, durchgehalten werden.

Candidamykosen der Haut werden lokal, z. B. mit Nystatin (z. B. Candio-Hermal®) oder Miconzol (z. B. Infectosoor® Zinksalbe), therapiert. Bei schwerem Befall ist die orale Gabe von Fluconazol (z. B. Flunazol®) oder Itraconazol (z. B. Itraderm®) nötig.

Maßgeblich für den Therapieerfolg ist das Trockenhalten von feuchten Körperstellen:

- Nässende Hautpartien (bspw. Zehenzwischenräume) z. B. mit Povidontinktur (etwa Betaisodona®) oder gerbstoffhaltigen Externa (etwa Tannolact®) behandeln
- Für Waschungen antiseptische Waschlotionen, z. B. Betaisodona® Wasch-Antiseptikum, benutzen, dabei stets Handschuhe tragen. Alkalische Seifen meiden. Infizierte Areale zuletzt waschen, Waschlappen und Handtuch danach entsorgen oder Einmalartikel verwenden. Körperstellen, die sich schlecht abtrocknen lassen, z. B. die Zehenzwischenräume, trocken föhnen (nicht zu heiß)

- Auf ausgedehnte warme Bäder verzichten. Sie lassen die Haut aufquellen, wodurch die Pilzsporen leichter in die Haut eindringen können
- In Körperstellen, an denen Haut auf Haut liegt (z. B. Zehenzwischenräume, Leisten, weibliche Brüste), Mullstreifen oder Kompressen aus Baumwolle einlegen. Diese sorgen für „Abstand und Belüftung“ und saugen den Schweiß auf
- Alle Utensilien (z. B. Waschschüssel, Steckbecken) nach Gebrauch mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (wirksam gegen Pilze und Sporen) wischdesinfizieren, Einwirkzeit beachten.
- Betroffene bezüglich geeigneter Kleidung beraten. Ideal ist kochbare, atmungsaktive Wäsche aus Naturmaterialien, ungünstig ist Kleidung aus synthetischen Fasern, über die der Schweiß nicht verdunsten und die nicht heiß (mind. 60 °C) gewaschen werden kann
- Strümpfe aus Baumwolle bevorzugen
- (Möglichste offene) Schuhe aus Leder tragen, keine Gummistiefel o. Ä. tragen
- Schuhe mit pilzabtötendem Spray/Puder behandeln, beispielsweise Calcifu® Spray.

Maßnahmen zur Vorbeugung von Fußpilz sind:

- Information über häufige Übertragungswege: Barfußgehen in öffentlichen Bädern, Sportvereinen oder Hotels (Badesandalen tragen), oder Schuhe, die von mehreren Leuten getragen werden. Die Fußsprühanlagen in Schwimmbädern sind wegen des Sensibilisierungsrisikos und unzuverlässiger Wirksamkeit nicht empfehlenswert
- Vermeiden feuchter Zehenzwischenräume durch gründliches Abtrocknen der Füße, Baumwollsocken und Lederschuhe
- Unspezifische Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems, z. B. gesunde Ernährung, regelmäßig körperliche Aktivität
- Während der Infektion Tragen von Badeschuhen auch zu Hause, um Familienmitglieder nicht anzustecken.

Foto Medikament Salbe Canesten:

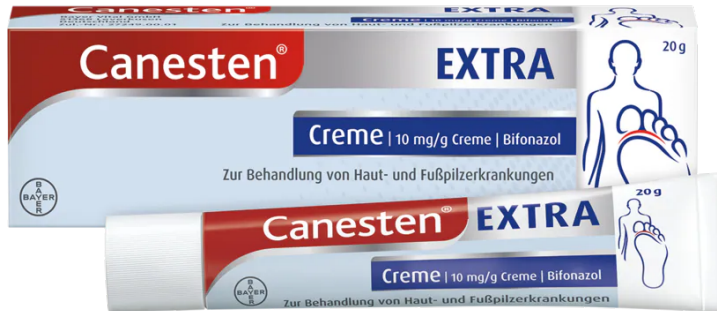


Foto Medikament Salbe Lotricomb:



Foto Medikament Nagellack Ciclopoli:



Foto Medikament Terbinafin Tabletten:



Foto Zinksalbe Infectosoos:



Foto Salbe Betaisadona:



Foto Mykose Zehenzwischenräume:

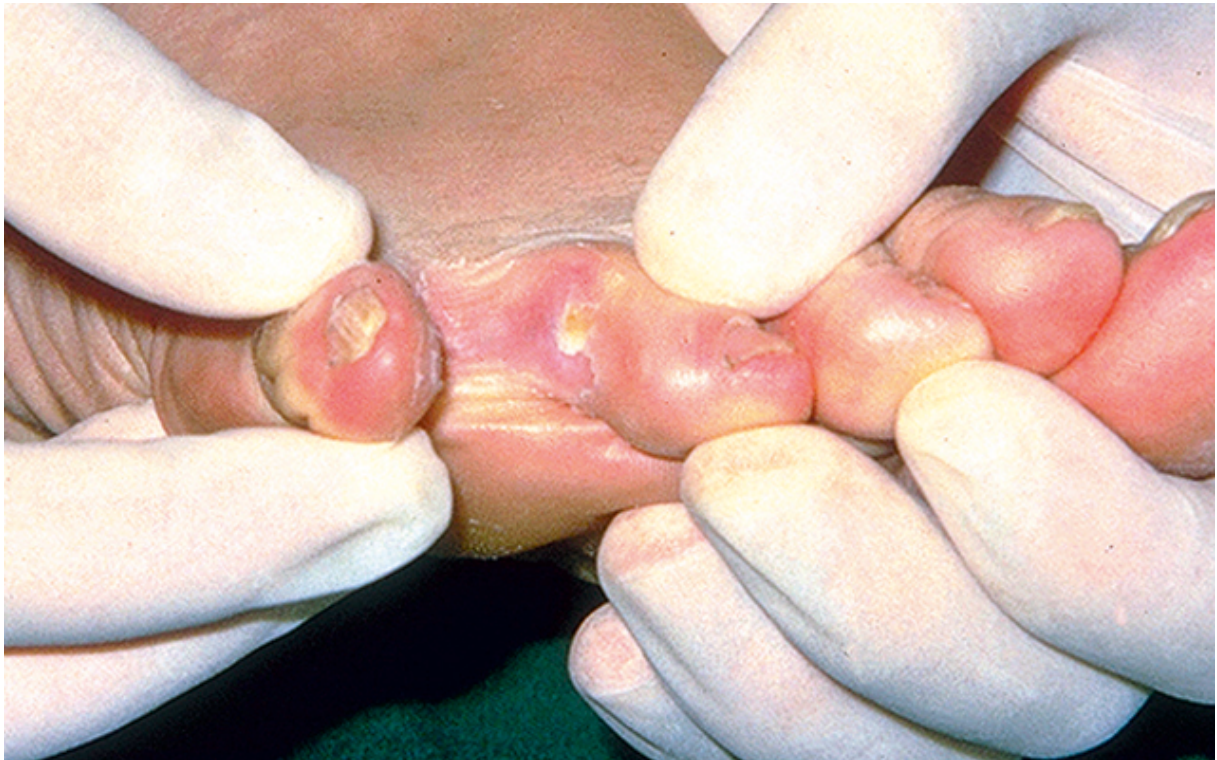


Foto Nagelmykose:



Foto Dermatophyteninfektion:

